

갑상선 결절, 언제 검사하고 언제 지켜볼까요?

초음파 모양(K-TIRADS)과 크기 기준으로 필요한 검사만 정확히 고릅니다.



광교바른내과

갑상선 초음파 안내

CORE MESSAGE

결절이 보인다고 모두 세침흡인검사를 하지는 않습니다.

좋은 모양은 지켜보고, 의심 모양은 기준 크기에서 확인합니다. 검사 뒤에는 Bethesda class에 따라 추적 방향이 달라집니다.

STEP 1

모양

초음파에서 양성
모양인지, 의심 소견이
있는지 봅니다.

STEP 2

크기

등급별 FNA 기준을
넘는지 확인합니다.

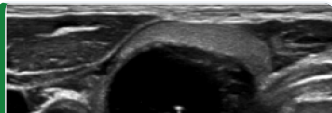
STEP 3

결과

Bethesda 결과와
초음파를 합쳐 추적
계획을 정합니다.

K-TIRADS 초음파 모습과 FNA 기준

대표 초음파 예시와 검사 기준을 함께 봅니다



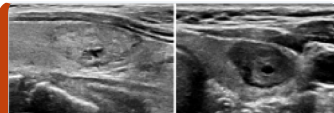
K-TIRADS 2

양성

전형적 양성 모양

해면모양, 순수 낭종, 낭성 부분 안
해성꼬리 인공음영.

FNA: 일반적으로 안 함



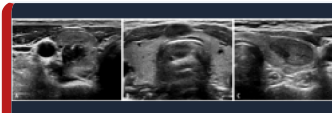
K-TIRADS 3

낮은의심

작으면 추적 우선

부분 낭성 또는 등/고에코 결절이며 3대
의심소견이 없음.

FNA: > 2.0 cm



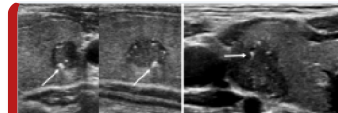
K-TIRADS 4

중간의심

정밀 확인 후보

의심소견 없는 저에코 고형결절,
의심소견 동반 등/고에코, 완전 석회화.

FNA: > 1.0-1.5 cm



K-TIRADS 5

높은의심

놓치면 안 되는 군

저에코 고형결절에 점상 고에코, 세로로
긴 모양, 불규칙 경계 중 하나.

FNA: > 1.0 cm

크기 기준 — 검사할 결절을 고르는 법

K2

일상적 FNA 없음. 커져서 치료 계획이 필요하거나 절제술 전 확인이
필요하면 예외.

K3

2 cm 초과부터 FNA 고려. 작고 안정적이면 추적 위주.

K4

1-1.5 cm 초과. 위치, 초음파 소견, 임상 위험인자, 선호도에 따라
결정.

K5

1 cm 초과부터 FNA. 림프절 전이, 명백한 외부 침범 등은 크기와
무관.

Suspicious features — 의심 신호

점상 고에코

미세석회화처럼 보이는 작은 밝은 점.
고형 저에코 결절 안에 있으면 더
경계합니다.

세로로 긴 모양

taller-than-wide. 옆보다 앞뒤로 더
깊게 자라는 형태입니다.

불규칙 경계

빼죽하거나 미세엽상 경계. 주변으로
파고드는 듯한 의심도가 올라갑니다.

임상 고위험

의심 림프절, 명백한 외부 침범, 원격
전이, 수질암 의심은 크기 기준보다
우선합니다.

세침흡인검사 결과: Bethesda class별 다음 단계

결과지만 보지 말고, 초음파 위험도와 같이 봅니다

Class	결과	성인 암위험	이후 관리 흐름
I	비진단	약 13%	초음파 유도 재검. 반복 비진단·성장·강한 의심이면 CNB 또는 진단적 수술 고려.
II	양성	약 4%	즉시 치료는 보통 불필요. K5 모양은 6-12개월, K3/4는 12-24개월 후 재평가.
III	AUS	약 22%	재FNA, CNB, 분자검사, 추적 또는 진단적 수술 중 선택.
IV	여포종양	약 30%	진단적 엽절제술을 주로 고려. 분자검사 결과에 따라 선택적 추적 가능.
V-VI	악성 의심/악성	약 74-97%	수술 평가가 기본. 성인 저위험 미세유두암은 조건이 맞으면 적극적 관찰도 논의.

오늘 가져갈 한 줄

결절 발견은 출발점입니다. 좋은 모양은 지켜보고, 의심 모양은 기준 크기에서 확인합니다.
의미 있는 성장 또는 새 의심소견이 생기면 판정을 업데이트합니다.

기준일: 2026-05-13. 근거: 2021 K-TIRADS consensus, 2023/2024 대한갑상선학회
갑상선결절 진료권고안, 2023 Bethesda System. 초음파 예시 이미지: Ha EJ et al., **Korean
J Radiol.** 2021, CC BY-NC 4.0.

